



PROTEKSI ISI PROPOSAL

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi proposal ini dalam bentuk apapun kecuali oleh pengusul dan pengelola administrasi pengabdian kepada masyarakat

PROPOSAL PENELITIAN 2024

Rencana Pelaksanaan Penelitian: tahun 2024 s.d. tahun 2024

1. JUDUL PENELITIAN

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di beberapa Puskesmas di Bandar Lampung (Penelitian Multicenter-Cross Sectional)

Bidang Fokus	Tema	Topik (jika ada)	Prioritas Riset
Kesehatan	Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kemandirian obat	Penguatan pengetahuan dan pengembangan kebiasaan masyarakat dalam berperilaku sehat	Kemandirian Kesehatan

Rumpun Ilmu Level 1	Rumpun Ilmu Level 2	Rumpun Ilmu Level 3
ILMU KESEHATAN	ILMU FARMASI	Farmakologi dan Farmasi Klinik

Skema Penelitian	Strata (Dasar/Terapan/Pengembangan)	Nilai SBK	Target Akhir TKT	Lama Kegiatan
Penelitian Dosen Pemula	Riset Dasar	50.000.000	3	1 Tahun

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	Jenis	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta
DIRGA 0011068901 Ketua Pengusul Institut Teknologi Sumatera	Dosen	Farmasi	Mendesain penelitian, menyusun instrument, pengambil data, Mendesain penelitian, menyusun instrument, pengambil data	6652021
NURUL IRNA WINDARI 0008029405 Anggota Institut Teknologi Sumatera	Dosen	Farmasi	Mendesain penelitian, menyusun instrument pengambil data, memantau pengumpulan data, menganalisis data, menyusun laporan, menyusun draft jurnal	6798901
apt. Novrilia Atika Nabila, S.Farm., M.Clin.Pharm 1802117011940002 Anggota Institut Teknologi Sumatera	Umum	Farmasi Klinik	Menyusun instrument pengambil data, memantau pengumpulan data, menganalisis data, menyusun laporan, menyusun draft jurnal	-

3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (Jika Ada)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra	Dana
-------	------------	------

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Kategori Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian	Keterangan
1	Artikel di Jurnal	Artikel di Jurnal Bereputasi Nasional Terindeks SINTA 1-4	Accepted/Published	https://jurnal.ugm.ac.id/jmpf -- Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi -- Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

5. ANGGARAN

Rencana Anggaran Biaya penelitian mengacu pada PMK dan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

Total RAB 1 Tahun Rp43.000.000,00

Tahun 1 Total Rp43.000.000,00

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Souvenir Responden	Unit	600	15.000	9.000.000
Bahan	ATK	Pena cair Joyko	Paket	9	30.000	270.000
Bahan	ATK	Pulpen Pilot	Paket	50	15.000	750.000
Bahan	ATK	Kerta A4 70 gram	Paket	6	60.000	360.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Isian Staples	Unit	6	60.000	360.000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	Pembantu Lapangan 4	OH	30	50.000	1.500.000
Bahan	ATK	Pulpen Foster	Paket	3	30.000	90.000
Bahan	ATK	Kertas Buffalo	Paket	4	22.000	88.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya konsumsi rapat	Konsumsi Rapat (Makan)	OH	30	40.000	1.200.000
Bahan	Barang Persediaan	Buku Pedoman Diabetes Mellitus Tipe 2	Unit	1	450.000	450.000
Bahan	ATK	Tip-Ex Pita Joyko	Paket	3	75.000	225.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Fotokopi Kuisi	Unit	500	1.000	500.000
Bahan	Barang Persediaan	Staples	Unit	6	25.000	150.000
Bahan	ATK	Pensil Warna	Paket	5	33.000	165.000
Bahan	ATK	Binder clip besar	Paket	2	25.000	50.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Cetak dan Jilid Laporan	Unit	3	150.000	450.000
Bahan	Barang Persediaan	Papan Ujian Butterfly	Unit	6	25.000	150.000
Bahan	ATK	Kertas HVS F4	Paket	3	60.000	180.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya konsumsi rapat	Konsumsi Rapat (Snack)	OH	30	21.000	630.000
Bahan	ATK	Lakban Bening	Paket	5	10.000	50.000
Pengumpulan Data	Transport	Perjalanan (BBM)	OK (kali)	40	100.000	4.000.000
Bahan	ATK	Pensil	Paket	4	20.000	80.000
Bahan	ATK	Map Plastik Aneka	Paket	10	65.000	650.000
Bahan	Bahan Penelitian	Izin Penelitian (Dinas Kesehatan)	Unit	1	1.500.000	1.500.000

Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
	(Habis Pakai)					
Bahan	ATK	Hand Sanitizer Secret Clean	Paket	12	25.000	300.000
Bahan	ATK	Map kancing	Paket	6	15.000	90.000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	Pembantu Lapangan 3	OH	30	50.000	1.500.000
Analisis Data	HR Pengolah Data	Analisis Data Statistik	P (penelitian)	1	1.000.000	1.000.000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Izin Kode Etik Penelitian (FK UGM)	Unit	1	500.000	500.000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	Pembantu Lapangan 5	OH	30	50.000	1.500.000
Bahan	ATK	Paper Clip Joyko Kecil	Paket	2	8.000	16.000
Bahan	ATK	Masker Sensi Dukbil	Paket	4	300.000	1.200.000
Bahan	Barang Persediaan	Flashdisk 128 G	Unit	3	120.000	360.000
Bahan	ATK	Tinta Printer Epson warna	Paket	3	350.000	1.050.000
Bahan	ATK	Map Resleting	Paket	6	25.000	150.000
Bahan	ATK	Map Kertas	Paket	2	80.000	160.000
Bahan	ATK	Tinta Printer Epson Hitam	Paket	2	300.000	600.000
Bahan	ATK	Sticker sign	Paket	15	20.000	300.000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	Pembantu Lapangan 6	OH	30	50.000	1.500.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Bereputasi Nasional	Jurnal Sinta 2	Paket	1	2.000.000	2.000.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Uang harian rapat di luar kantor	Uang Harian Rapat	OH	10	95.000	950.000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	Pembantu Lapangan 2	OH	30	50.000	1.500.000
Bahan	ATK	Buku Tulis Sidu	Paket	3	15.000	45.000
Bahan	ATK	Stabilo Faber Castle	Paket	1	46.000	46.000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	Pembantu Lapangan 1	OH	30	50.000	1.500.000
Pelaporan Hasil Penelitian dan Luaran Wajib	Biaya Pendaftaran KI	Konfrensi Nasional/ Internasional	Paket	1	3.000.000	3.000.000
Bahan	ATK	Kotak Pencil Kain	Paket	15	35.000	525.000
Bahan	ATK	Gunting	Paket	6	60.000	360.000



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN DASAR (PENELITIAN DOSEN PEMULA AFFIRMASI, PENELITIAN DOSEN PEMULA, PENELITIAN PASCASARJANA)

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di beberapa Puskesmas di Bandar Lampung (Penelitian *Multicenter-Cross Sectional*)

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan dan membutuhkan manajemen terapi serta perawatan diri agar mencapai target kualitas hidup pasien yang baik. Kualitas hidup pasien DM dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor demografi, faktor, faktor medis yaitu lama menderita, komplikasi yang dialami dan faktor kepatuhan mengkonsumsi obat. **Tujuan dari penelitian ini adalah** untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe 2 di beberapa puskesmas di Bandar Lampung. Rancangan penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental (deskriptif-analitik) dengan desain potong lintang (*cross sectional*) yang dilakukan di beberapa puskesmas di Bandar Lampung. Pengambilan subjek uji dilakukan dengan metode *consecutive sampling* yaitu semua pasien yang datang dan memenuhi kriteria inklusi serta menyetujui *informed consent*. Sampel yang digunakan adalah pasien DM Tipe 2 yang berobat rawat jalan di beberapa puskesmas di Bandar Lampung dan telah mendapatkan terapi minimal sebulan sebelum penelitian dilaksanakan. Pengukuran Kualitas hidup pasien menggunakan kuisioner *Short Form-36*. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis bivariat dengan menggunakan uji *chi square* kemudian dilanjutkan ke uji multivariat dengan menggunakan regresi logistic untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas hidup pasien DM tipe 2.

Luaran yang ditargetkan meliputi keterbaruan informasi terkait faktor yang memepengaruhi kualitas hidup pasien Diabetes Mellitus. Target luaran pada penelitian ini yaitu jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 (Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi/JMPF). Tahap Kesiapan Teknologi pada penelitian ini yaitu level 3

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

DM Tipe 2; faktor-faktor; Kualitas Hidup; Puskesmas; Bandar Lampung

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

- Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
- Pendekatan pemecahan masalah
- State of the art dan kebaruan
- Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

D.1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini

Diabetes melitus (DM) menyebabkan kematian prematur di seluruh dunia. Penyakit ini juga menjadi penyebab utama kebutaan, penyakit jantung, dan gagal ginjal [1]. Diabetes masih menjadi masalah Kesehatan yang penting yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya [15]. Indonesia merupakan negara ke-7 dari 10 besar negara yang diperkirakan memiliki jumlah penderita DM sebesar 5,4 juta pada tahun 2045 serta memiliki angka kendali kadar gula darah yang rendah [2]. Indonesia berada di peringkat ke-7 di antara 10 negara dengan jumlah penderita terbanyak, yaitu sebesar 10,7 juta dan menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke daftar tersebut [1]. Riskesdas 2018 menunjukkan jumlah diabetes melitus di Indonesia pada umur diatas 15 tahun sebanyak 2%. Namun jumlah pasien diabetes berdasarkan hasil tes gula darah persentasinya 2013 bertambah yang awalnya 6.9%, menjadi 8,5% pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% orang diabet yang tahu bahwa dirinya memiliki penyakit diabetes [1].

Meningkatnya kasus diabetes dalam jangka waktu tertentu dapat berpengaruh terhadap kejadian komplikasi berupa baik makrovaskular maupun mikrovaskular yang akan dialami oleh penderita dan dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien diabetes melitus [3], [4]. Kualitas hidup juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Kualitas hidup yang buruk akan semakin memperburuk kondisi suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit kronis yang sangat sulit disembuhkan salah satunya seperti DM [3], [4]. Penelitian terdahulu terkait kualitas hidup pada pasien DM menunjukkan mayoritas pasien DM memiliki kuliatas hidup yang buruk/menurun serta penurunan pada aspek-aspek seperti fungsi fisik, mental, sosial, dan kesehatan umum [5], [6], [7].

Kualitas hidup terkait kesehatan (HRQoL) adalah konsep multidimensi yang mempertahankan persepsi individu tentang kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial [16]. Bagi penderita diabetes kronis, kondisinya tidak mungkin bisa disembuhkan sepenuhnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kondisi pasien tetap stabil baik fisik maupun mental. Selain itu, penting untuk memahami prediktor dan mengidentifikasi faktor risiko HRQoL untuk mengembangkan intervensi dan pengobatan komprehensif untuk pasien diabetes [17]. Menilai HRQoL pada pasien diabetes adalah topik yang populer dengan banyak penelitian yang dilakukan di seluruh dunia [18] [19] [20]. Ada banyak faktor yang terkait dengan HRQoL, beberapa di antaranya telah dibahas. Sebagian besar Penelitian menemukan hubungan antara HRQoL dan variabel berikut: indeks massa tubuh (BMI), faktor risiko terkait (dislipidemia, hipertensi, dll usia, jenis kelamin, status ekonomi, Tingkat pendidikan, pilihan gaya hidup) [17].

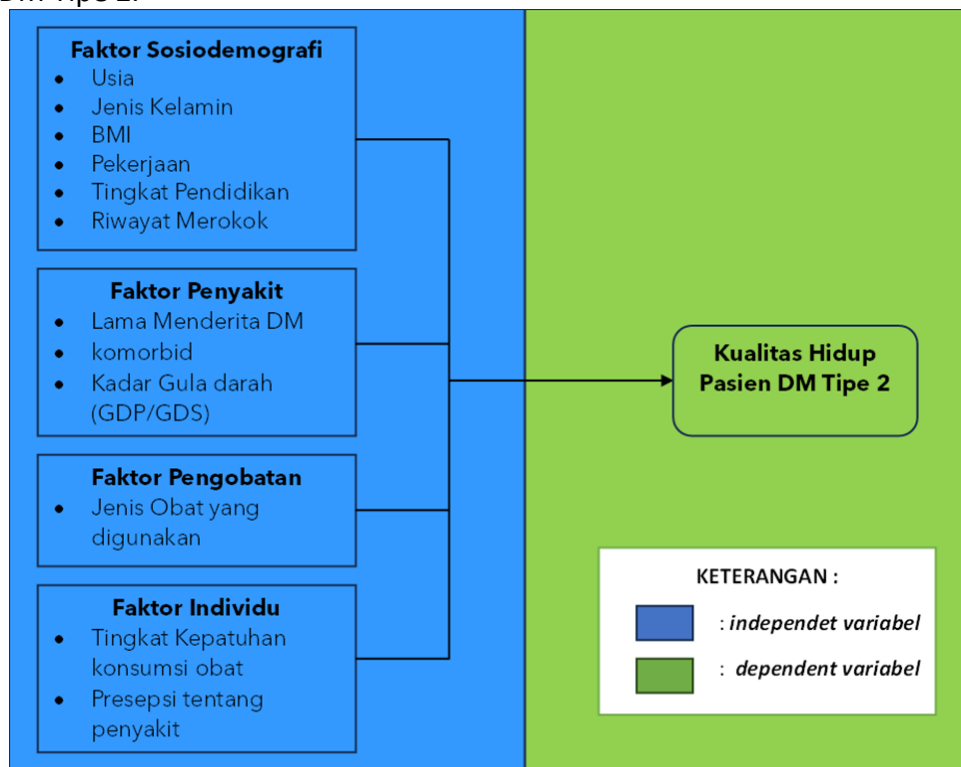
DM membutuhkan manajemen terapi serta perawatan diri agar mencapai target kualitas hidup pasien yang baik. Suatu review menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien DM yaitu faktor lama menderita diabetes mellitus, komplikasi diabetes mellitus, *self management* atau *self care*, pendidikan, jenis kelamin, dan usia [8]. Terdapat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus [8] [9]. DM2 adalah merupakan salah satu penyakit kronis yang sebagian besar merupakan pasien BPJS Kesehatan yang mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah melalui pembentukan program peserta penderita penyakit kronis (Prolanis) [10]. Program Prolanis banyak di jalankan pada puskesmas yang merupakan fasilitas Kesehatan primer (Tingkat pertama) yang secara rutin menjadi fasilitas Kesehatan tempat kontrol pengobatan pasien DM2. **Berdasarkan pemaparan diatas perlu dilakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien Diabetes Melitus Tipe 2. Domain faktor yang akan dianalisis meliputi faktor sosiodemografi, faktor penyakit, faktor pengobatan dan faktor individu yang ditunjukkan**

dengan persepsinya terhadap penyakit. Pada penelitian ini akan digunakan beberapa instrument untuk mengukur faktor-faktor tersebut yaitu SF 36 untuk mengukur kualitas hidup, MMAS-8 untuk mengukur kepatuhan terhadap pengobatan dan persepsi dengan *Brief Illness Perceptions Questionnaire* (B-IPQ).

D.2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas hidup pasien Diabetes Melitus Tipe 2. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukannya suatu penelitian deskripti-analitik melalui pendekatan *crosssectional* dengan variabel-variabel penelitian yaitu, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien DM tipe 2 (faktor sosiodemografi, penyakit, pengobatan, dan individu) sebagai variabel bebas (*independent variabel*) dan kualitas hidup pasien pasien DM tipe 2 sebagai variabel terikat (*dependent variabel*). Masing-masing variabel bebas akan dihubungkan kepada variabel terikat secara bivariat, dan analisis variabel bebas yang secara statistik memiliki hubungan bermakna dengan variabel terikat akan dilanjutkan dengan analisis hubungan secara regresi (multivariat) untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien DM Tipe 2.



Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian

D.3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN

Tuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama, serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan, metode, dsb

Informasi data *baseline* terkait faktor risiko yang paling mempengaruhi kualitas hidup pada pasien DM tipe 2, sehingga dapat digunakan untuk pengembangan pengobatan pasien DM tipe 2 yang berbasis kualitas hidup. Beberapa penelitian lain terkait dalam konteks permasalahan yang sama seperti dalam tabel berikut.

Judul (Tahun Penelitian)	Desain Penelitian	Variabel Penelitian	Analisa Statistik
--------------------------	-------------------	---------------------	-------------------

<i>The impact of diabetes mellitus on quality of life differences between genders (2018) [11]</i>	<i>Transversal survey study</i>	Variabel bebas : Jenis kelamin Variabel terikat : Kualitas hidup (kuisisioner B-PAID)	Perbandingan antara skor jenis kelamin, kualitas hidup, kepatuhan pengobatan, dan dampak diabetes dianalisis menggunakan <i>Teste t-Student</i>
<i>Quality of life of people with diabetes mellitus (2019) [12]</i>	<i>Quantitative, cross-sectional and descriptive study</i>	Variabel bebas : Faktor sosiodemografi (jenis kelamin, usia, asal daerah, status pernikahan, status pendidikan, dan status pekerjaan). Faktor diagnosa klinis (lama diabetes, BMI, tekanan darah, komplikasi, komorbid, HbA1c, dan GDP) Variabel terikat : Kualitas hidup (kuisisioner Diabetes-39 (D-39))	Hubungan kualitas hidup dengan variabel sosiodemografi, variabel klinis dan tes laboratorium dengan uji koefisien korelasi spearman
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Instalasi Rawat Jalan RSUD Sukoharjo Tahun 2020 (2020) [13]	<i>Cross sectional dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling</i>	Variabel bebas : Jenis kelamin, usia, BMI, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lama menderita diabetes, pengobatan, polifarmasi, komplikasi, komorbid, dan jaminan kesehatan Variabel terikat : Kualitas hidup (kuisisioner DQLCTQ/ <i>Diabetes Quality of Life Clinical Trial Questionnaire</i>).	Analisis perbedaan skor kualitas hidup antar variabel menggunakan uji <i>independent sampel t-test</i> . Analisis pengaruh antar variabel menggunakan uji regresi linier berganda dengan metode <i>enter</i>
<i>Quality of life and factors associated with a good quality of life among diabetes mellitus patients in northern Thailand (2022) [14]</i>	<i>Cross-sectional</i>	Variabel bebas : Usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, jumlah anggota keluarga yang tinggal bersama, merokok, minum alkohol, olahraga, stress, pengetahuan dan sikap terkait pencegahan dan	Hubungan antara variabel bebas dengan kualitas hidup menggunakan analisa <i>chi-square</i> dan <i>logistic regression</i>

		kontrol diabetes, lama menderita diabetes, efek samping, ulkus pada kaki, komplikasi, komorbid, dan biaya pengobatan Variabel terikat :Kualitas hidup (kuisisioner WHOQOL-BREF)	
--	--	--	--

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut di atas, faktor risiko tambahan yang dikaji terhadap kualitas hidup pasien diabetes melitus yakni persepsi pasien terkait dengan penyakit dan jenis obat diabetes. Penelitian juga dilakukan pada *scope* yang lebih luas di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan/puskesmas (**multicenter**) dengan jumlah sampel pasien DM yang lebih banyak, sehingga diharapkan dapat mewakili gambaran populasi terkait kualitas hidup pasien DM dan faktor-faktor yang memengaruhinya, yang mana pada penelitian sebelumnya dominasi penelitian dilakukan di rumah sakit. Selain itu, pengukuran kualitas hidup menggunakan kuisisioner yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya yakni SF-36.

D.4. PETA JALAN PENELITIAN

Tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan.

Riset unggulan perguruan tinggi di ITERA disusun berdasarkan kelompok keilmuan yang berbasis pada program studi di masing masing fakultas. pada fakultas sains fokus penelitian kesehatan menjadi salah satu topik unggulan yang isu strategis di fakultas sains.



Gambar 2.2 Daftar Penelitian Unggulan Fakultas Sains ITERA

Riset unggulan yang berada pada fakultas sains diturunkan pada masing-masing kelompok keilmuan yang berbasis pada program studi.

Tabel 2.1. Roadmap Penelitian KK Farmakologi, Farmasi Klinik dan Komunitas Prodi Farmasi

Topik Penelitian	Survei dan Eksplorasi	Penanggulangan dan Pengembangan				Pematenan, Implementasi dan Pengelolaan Teknologi	Implementasi Berkelanjutan
Suplemen untuk Penyakit Gangguan Metabolik dan Penyakit Infeksi	- Survei penyakit, pola penggunaan dan tingkat pengetahuan masyarakat terkait suplemen - Eksplorasi bahan alam sebagai suplemen - Uji farmakologi efektivitas dan keamanan bahan aktif dan sediaan suplemen	- Evaluasi rasionalitas penggunaan suplemen untuk penyakit infeksi - Uji farmakologi efektivitas dan keamanan suplemen	- Evaluasi efektivitas penggunaan suplemen - Evaluasi farmakoeconomis penggunaan suplemen - Uji farmakologi efektivitas dan keamanan suplemen	Evaluasi dosis dan keamanan penggunaan suplemen	- Evaluasi kualitas hidup pada pasien pengguna suplemen - Evaluasi dosis dan keamanan suplemen	- Uji efektivitas dan keamanan sediaan suplemen pada subjek uji manusia - Pematenan - Bekerja sama dengan industry dalam implementasi teknologi	Evaluasi efektivitas dan keamanan pasca pemasaran

Penelitian ini mendukung penelitian di prodi farmasi pada kelompok keilmuan bidang farmakologi, farmasi klinik dan Komunitas tahun 2022-2034. Penelitian yang akan dilakukan menjadi penelitian awal yang berfungsi sebagai data *baseline* (survey dan eksplorasi) untuk mencari akar masalah yang terdapat pada penyakit-penyakit gangguan metabolit sehingga dapat menjadi data pendukung untuk pengembangan teknologi pfarmasi yang akan di kembangkan pada bidang keilmuan lain di prodi farmasi ITERA.



Gambar 2.3. Roadmap Penelitian

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metoda wajib dilengkapi dengan:

- Diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG.
- Metode penelitian harus memuat, sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian.
- Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

a. Desain Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental (deskriptif-analitik) dengan desain potong lintang (*cross sectional*) yang dilakukan di beberapa puskesmas di Bandar Lampung. Pengambilan subjek uji dilakukan dengan metode *consecutive sampling* yaitu semua pasien yang datang dan memenuhi kriteria inklusi serta menyetujui *informed consent*. Sampel yang digunakan adalah pasien DM Tipe 2 yang berobat rawat jalan di beberapa puskesmas di Bandar Lampung dan telah mendapatkan terapi minimal sebulan sebelum penelitian dilaksanakan. Faktor-faktor yang diukur pada penelitian ini terdiri dari 4 faktor meliputi faktor demografi (Usia, Jenis kelamin, BMI, Pekerjaan, Tingkat Pendidikan, Riwayat Merokok), faktor penyakit (Lama menderita DM, Komplikasi, Kadar gula darah), faktor pengobatan (Jenis obat yang digunakan), faktor individu (Tingkat kepatuhan konsumsi obat yang di ukur dengan menggunakan kuisioner *Morisky Medication Adherence* MMAS-8, persepsi tentang penyakit menggunakan *Brief Illness Perceptions Questionnaire* B-IPQ). Pengukuran Kualitas hidup pasien menggunakan kuisioner *Short Form*-36. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis bivariat dengan menggunakan *chi square* kemudian dilanjutkan ke multivariat dengan menggunakan regresi logistic untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas hidup pasien DM tipe 2

b. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada Juni-Oktober 2024 di beberapa puskesmas di Bandar Lampung.

c. Subyek Penelitian

Pengambilan subjek uji dilakukan dengan metode *consecutive sampling* yaitu semua pasien yang datang dan memenuhi kriteria inklusi serta menyetujui *informed consent* dimasukkan dalam penelitian. Pasien yang diambil adalah pasien yang kontrol rawat jalan di beberapa puskesmas di Bandar Lampung. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi subyek penelitian yaitu:

1. Kriteria inklusi:

- Pasien dengan diagnosa diabetes melitus tipe 2 dengan atau tanpa komplikasi
- Berusia >18 tahun.
- Mendapatkan terapi pengobatan antidiabetik oral dan atau insulin minimal selama 1 bulan sebelum penelitian dilakukan,
- Pasien mampu berkomunikasi, dapat membaca dan memahami kuisiонер.
- Bersedia mengikuti penelitian melalui *informed consent*.

2. Kriteria eksklusi:

- Pasien dengan catatan rekam medis tidak lengkap.
- Pasien yang tidak mengisi kuisiонер dengan lengkap.

d. Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan setelah mendapatkan izin pelaksanaan penelitian dari uji etik oleh Komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

e. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuisiонер dengan rincian sebagai berikut:

1. Lembar informasi umum pasien yang berisi karakteristik demografi meliputi jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, tingkat pendidikan, pekerjaan, Riwayat merokok.
2. Lembar isian yang berkaitan dengan riwayat kesehatan dan pengobatan subyek penelitian meliputi, GDS, GD2PP, GDP, lama menderita diabetes, komorbid, dan jenis obat DM yang digunakan.
3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisiонер, yaitu; *Morisky Medication Adherence* MMAS-8 untuk mengukur tingkat kepatuhan pasien, *Brief Illness Perceptions Questionnaire* B-IPQ untuk mengukur persepsi tentang penyakit, dan *Short Form-36* untuk mengukur Kualitas hidup pasien.

f. Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut

1. Tahap Persiapan

- a) Membuat Proposal

- b) Membuat *Ethical Clearance* (EC) ditujukan kepada pihak di Puskesmas.
- c) Mengurus surat ijin penelitian yang ditujukan kepada Dinas kesehatan, Kesbangpol dan kepala Puskesmas.

2. Tahap Pelaksanaan

- a) Pengamatan dilakukan dengan cara pengambilan data dari rekam medik pasien yang dilakukan dengan pengkodean pada identitas pasien. Data yang diambil berupa identitas pasien, riwayat kesehatan dan pengobatan dan profil gula darah pasien, komorbid.
- b) Penyebaran kuisisioner untuk mengukur kepatuhan, presepsi tentang penyakit dan kualitas hidup pasien DM tipe 2.

g. Pengolahan dan Analisis Data

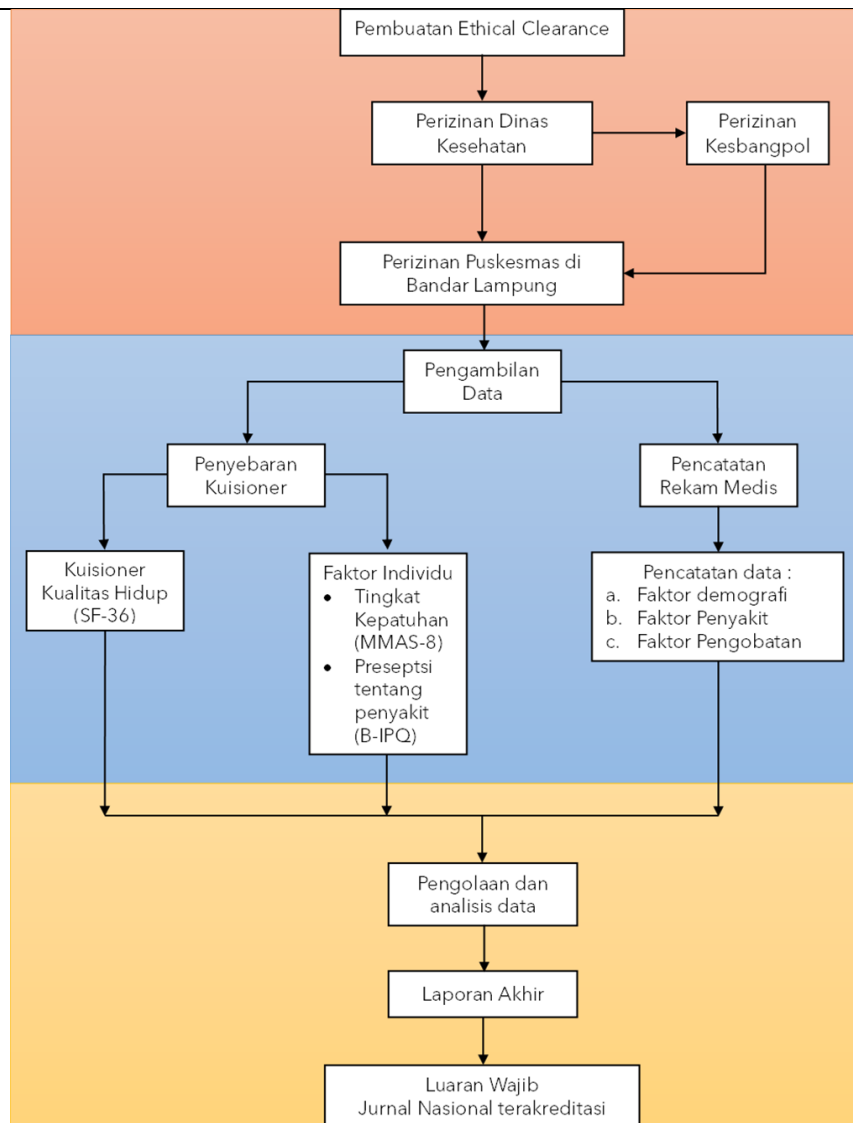
Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif non analitik dan analitik. Secara rinci, analisis data yang akan dilakukan yaitu:

1. Analisis Deskriptif. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan distribusi dari masing-masing variabel yang diteliti. Analisis univariat dilakukan untuk data karakteristik Demografi dan riwayat kesehatan serta pengobatan pasien.
2. Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan faktor sosiodemografi, faktor penyakit, faktor pengobatan dan faktor individu terhadap kualitas hidup pasien DM tipe 2 dengan menggunakan uji *Chi Square*. Dikatakan signifikan jika $p\text{ value} < 0,05\%$ (CI 95%).
3. Analisis Multivariat untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi terhadap kualitas hidup pasien DM tipe 2 dengan menggunakan uji regresi logistik.

h. Luaran dan Indikator Capaian Penelitian

Pada Penelitian ini, proses pengambilan data akan dilakukan sampai tercapainya sampel minimal Penelitian. Dimana tahap luaran dan indikator capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Luaran	Indikator Capaian
1. Gambaran Karakteristik pasien Diabetes Melitus tipe 2 di beberapa puskesmas di Bandar Lampung	1. Laporan Penelitian 2. Jurnal Nasional Terakreditasi
2. Gambaran Kualitas Hidup pasien Diabetes Melitus tipe 2 di beberapa puskesmas di Bandar Lampung	
3. Gambaran Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe 2 di beberapa puskesmas di Bandar Lampung	



Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian

Tabel Pembagian Tugas

Tahapan Penelitian	PIC
Pembuatan Izin Kode Etik	Nurul Irna Windari
Pengurusan Izin Penelitian di Dinas Kesehatan, Kasbangpol, Puskesmas di Bandar Lampung	Nurul Irna Windari
Pengambilan Data: Penyebaran data kuisioner	Novrilia Atika Nabila
Pengambilan data: Pencatatan Rekam Medik	Dirga
Pengolaan data dan analisis data	Dirga
Laporan Akhir dan Luaran Penelitian	Dirga

F. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

[Tahun ke-1

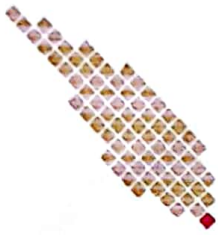
No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perijinan												
2	Pengambilan data												
3	Pengelolaan dan analisis data												
4	Penarikan kesimpulan												
5	Penyusunan laporan akhir												
6	Draft Publikasi												

G. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Kemenkes. (2020). Infodatin tetap produktif, cegah, dan atasi Diabetes Melitus 2020. In Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (pp. 1–10). <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin-2020-Diabetes-Melitus.pdf>
2. Sugiarta, I. G. R. M., & Darmita, I. G. K. (2020). Profil penderita Diabetes Mellitus Tipe-2 (DM-2) dengan komplikasi yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung, Bali tahun 2018. *Intisari Sains Medis*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.15562/ism.v11i1.515>
3. PERKENI. (2021). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021. PB PERKENI
4. Mulyani, A.Y., Arman, Patomah, S. (2023). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe II di Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Kabupaten Pinrang Tahun 2022. *Journal of Muslim Community Health (JMCH)* 2023. Vol. 4, No. 4. Page 345-357 doi: 10.33096/jmch.v4i4.1435
5. Roifah, I. (2016) 'Analisis Hubungan Lama Menderita Diabetes Mellitus Dengan Kualitas Hidup Penderita Diabetes Mellitus', *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 4(2).
6. Teli, M. (2017) 'Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Puskesmas Se Kota Kupang', *Jurnal Keperawatan Kupang*, 15(1), pp. 119–134.
7. Chaidir, R.dkk. (2017) 'Hubungan self care dengan kualitas hidup pasien diabetes melitus', *Journal Endurance*, 2(2) 2(June),. 132–144.
8. Khasanah, G.R., Widaryati. (2021) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus: Liters REVIEW. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
9. Kadang, Y, Awal, M., Abdullah, M.T., Herman, Zulfiah, Rusli. (2021). Factors Affecting The Quality Of Life In Patient With Diabetes Mellitus Type 2 At Public Health Center Of Sudiang. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*. ISSN : 2549-0567 (Online). Vol. XVI No. 2, Desember 2021 DOI: <https://doi.org/10.32382/medkes.v16i2.2293>
10. Febriawati, S. Siral, R. Yanuarti, E. Oktavidiati, N. Wati, and W. Angraini, "Pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)," *Citra Delima Sci. J. Citra Int. Inst.*, vol. 6, no. 2, pp. 105–110, Dec. 2022, doi: 10.33862/citradelima.v6i2.296.
11. Jorgetto, J. V., & Franco, L. J. (2018). The impact of diabetes mellitus on quality of life – differences between genders. *Journal of Diabetes & Metabolic Disorders*, 17(1), 11–17. <https://doi.org/10.1007/s40200-018-0333-y>
12. Khamilia, N., & Yulianti, T. (2021). Faktor-Farktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Di Instalasi Rawat Jalan RSUD Sukoharjo Tahun 2020. *Prosiding University Research Colloquium*, 494–507. Retrieved from <https://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1438>
13. Tamornpark, R., Utsaha, S., Apidechkul, T., Panklang, D., Yeemard, F., & Srichan, P. (2022). Quality of life and factors associated with a good quality of life among diabetes mellitus patients in northern Thailand. *Health and Quality of Life Outcomes*, 20(1), 81. <https://doi.org/10.1186/s12955-022-01986-y>
14. Tonetto, I. F. D. A., Baptista, M. H. B., Gomides, D. D. S., & Pace, A. E. (2019). Quality of life of people with diabetes mellitus. *Revista Da Escola de Enfermagem Da USP*, 53, e03424. <https://doi.org/10.1590/s1980-220x2018002803424>
15. K. L. Ong *et al.*, "Global, regional, and national burden of diabetes from 1990 to 2021, with projections of prevalence to 2050: a systematic analysis for the Global Burden of

- Disease Study 2021," *The Lancet*, vol. 402, no. 10397, pp. 203–234, Jul. 2023, doi: 10.1016/S0140-6736(23)01301-6.
16. Trikkalinou, A. K. Papazafiropoulou, and A. Melidonis, "Type 2 diabetes and quality of life," *World J. Diabetes*, vol. 8, no. 4, pp. 120–129, Apr. 2017, doi: 10.4239/wjd.v8.i4.120.
 17. N. T. Kien, N. P. Hoa, D. M. Duc, and J. Wens, "Health-related quality of life and associated factors among patients with type II diabetes mellitus: A study in the family medicine center (FMC) of Agricultural General Hospital in Hanoi, Vietnam," *Health Psychol. Open*, vol. 8, no. 1, Jun. 2021, doi: 10.1177/2055102921996172.
 18. B. Arifin *et al.*, "Health-related quality of life in Indonesian type 2 diabetes mellitus outpatients measured with the Bahasa version of EQ-5D," *Qual. Life Res. Int. J. Qual. Life Asp. Treat. Care Rehabil.*, vol. 28, no. 5, pp. 1179–1190, May 2019, doi: 10.1007/s11136-019-02105-z.
 19. T. B. Pham *et al.*, "Effects of Diabetic Complications on Health-Related Quality of Life Impairment in Vietnamese Patients with Type 2 Diabetes," *J. Diabetes Res.*, vol. 2020, p. 4360804, 2020, doi: 10.1155/2020/4360804.
 20. "Scoring Mental Health Quality of Life With the SF-36 in Patients With and Without Diabetes Foot Complications - PubMed." Accessed: Jun. 25, 2024. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29546783/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: lppm@itera.ac.id, Website : <http://lppm.itera.ac.id>

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : apt. dirga., S.Farm., M.Sc.

NIDN : 0011068901

Instansi : Institut Teknologi Sumatera

Sehubungan dengan Kontrak Penelitian:

Tanggal Kontrak Induk* : 11 Juni 2024

Nomor Kontrak Induk* : 039/E5/PG.02.00.PL/2024

Tanggal Kontrak Turunan** : 11 Juni 2024

Nomor Kontrak Turunan** : 1570f/IT9.2.1/PT.01.03/2024

Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas
Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Beberapa
Puskesmas di Bandar Lampung (Penelitian
Multicenter-Cross Sectional)

Tahun Usulan : 2024

Tahun Pelaksanaan : 2024

Jangka Waktu Penelitian : 1 tahun

Periode Penelitian : Tahun ke 1 dari 1 tahun*

Dana Penelitian :

Periode	Dana Penelitian (Rp)	Dana Tambahan (Rp)
Tahun ke- 1	Rp. 43.000.000	-

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan penelitian serta mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut diatas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lampung Selatan, 24 Juni 2024



(apt. dirga., S.Farm., M.Sc.)

PERSETUJUAN PENGUSUL

Tanggal Pengiriman	Tanggal Persetujuan	Nama Pimpinan Pemberi Persetujuan	Sebutan Jabatan Unit	Nama Unit Lembaga Pengusul
31/03/2024	31/03/2024	JAHDI ZAIM	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Komentar : Disetujui

Disetujui, topik dan kajian usulan penelitian orisinal, sangat menarik dan penting dilakukan

INFORMED CONSENT PENELITIAN KESEHATAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HIDUP PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI BEBERAPA PUSKESMAS DI BANDAR LAMPUNG (PENELITIAN MULTICENTER-CROSS SECTIONAL)

Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan dan membutuhkan manajemen terapi serta perawatan diri agar mencapai target kualitas hidup pasien yang baik. Kualitas hidup pasien DM dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor demografi, faktor, faktor medis yaitu lama menderita, komplikasi yang dialami dan faktor kepatuhan mengkonsumsi obat. DM membutuhkan manajemen terapi serta perawatan diri agar mencapai target kualitas hidup pasien yang baik. Suatu review menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien DM yaitu faktor lama menderita diabetes mellitus, komplikasi diabetes mellitus, *self-management* atau *self-care*, pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas hidup pasien diabetes melitus tipe 2 di beberapa puskesmas di Bandar Lampung.

Rancangan Penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental (deskriptif-analitik) dengan desain potong lintang (cross sectional) yang dilakukan di beberapa puskesmas di Bandar Lampung. Pengambilan subjek uji dilakukan dengan metode consecutive sampling yaitu semua pasien yang datang dan memenuhi kriteria inklusi serta menyetujui informed consent. Sampel yang digunakan adalah pasien DM Tipe 2 yang berobat rawat jalan di beberapa puskesmas di Bandar Lampung dan telah mendapatkan terapi minimal sebulan sebelum Penelitian dilaksanakan. Pengukuran Kualitas hidup pasien menggunakan kuisioner Short Form-36. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis bivariat dengan menggunakan uji chi square kemudian dilanjutkan ke uji multivariat dengan menggunakan regresi logistic untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas hidup pasien DM tipe 2.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2 di beberapa puskesmas di bandar Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengobatan pasien untuk meminimalkan resiko permasalahan akibat obat sehingga

tercapai hasil terapi yang diharapkan. Setelah penjelasan tersebut, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / Umur :

Alamat :

No. telepon :

Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan ***coret yang tidak perlu**

Menyatakan BERSEDIA menjadi peserta penelitian dengan kesediaan untuk diwawancarai mengenai pengetahuan dan kepatuhan minum obat.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Peneliti

Lampung Selatan,

Yang membuat pernyataan

Dirga

.....

KUISIONER PENELITIAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HIDUP PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI BEBERAPA PUSKESMAS DI BANDAR LAMPUNG (PENELITIAN MULTICENTERCROSS SECTIONAL

Petunjuk pengisian :

Bapak/Ibu/Saudara/I diharapkan :

1. Menjawab semua pertanyaan yang kami berikan
2. Untuk pertanyaan tentang karakter sesiodemografi dan monitoring efek samping silahkan menjawab tiap pertanyaan yang tersedia dengan memberikan checklist (√) pada tempat yang telah disediakan untuk pertanyaan yang bapak/ibu/saudara/I anggap sesuai.

A. Data demografi

1. Kode (diisi peneliti) :
2. Usia responden :
3. Jenis kelamin : () Laki-laki
() Perempuan
4. Berat Badan :
5. Tinggi Badan :
6. Pendidikan terakhir : () Tidak Sekolah
() Tidak Tamat SD
() SMP
() SD
() SMA/SLTA
() Diploma/Sarjana*
7. Pekerjaan :
8. Status Merokok : () Ya () Tidak

9. Lama Menderita DM :

10. Kadar Gula Darah : (GDS/GD2PP/GDP)* (mg/dl)

11. Kapan didiagnosa DM : (dalam tahun)

Dimana didiagnosa DM Klinik/Puskesmas/Lain-lain, sebutkan*

*Lingkari Jawaban Yang benar.

Instrumen Survei Bentuk Pendek 36 Item (SF 36)

Pilih satu opsi untuk setiap pertanyaan kuisioner

Petunjuk pengisian: Pilihlah jawaban sesuai dengan yang bapak/ibu ketahui, dengan memberi tanda (V) pada kolom yang telah disediakan.

1. Secara umum, menurut Anda, kesehatan Anda adalah:

- ☐ 1-Luar biasa
- ☐ 2-Sangat baik
- ☐ 3-Baik
- ☐ 4-Cukup
- ☐ 5-Kurang

2. **Dibandingkan satu tahun yang lalu**, bagaimana Anda menilai kesehatan Anda secara umum saat ini?

- ☐ 1 - Saat ini jauh lebih baik dibandingkan satu tahun yang lalu
- ☐ 2 - Saat ini agak lebih baik dibandingkan satu tahun yang lalu
- ☐ 3 – Hampir sama
- ☐ 4.- Saat ini agak lebih buruk dibandingkan satu tahun yang lalu
- ☐ 5.- Saat ini jauh lebih buruk dibandingkan satu tahun yang lalu

Berikut adalah aktivitas yang mungkin Anda lakukan pada hari-hari biasa. Apakah **kesehatan Anda sekarang membatasi Anda** dalam melakukan aktivitas ini? Jika ya, seberapa besar?

	Ya, sangat terbatas	Ya, sedikit terbatas	Tidak, tidak terbatas sama sekali
3. Aktivitas berat , seperti berlari, mengangkat benda berat, mengikuti olahraga berat	☐ 1	☐ 2	☐ 3
4. Aktivitas sedang , seperti memindahkan meja, mendorong penyedot debu, bermain bowling, atau bermain golf	☐ 1	☐ 2	☐ 3
5. Mengangkat atau membawa barang belanjaan	☐ 1	☐ 2	☐ 3
6. Menaiki beberapa anak tangga	☐ 1	☐ 2	☐ 3

- | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7. Menaiki satu anak tangga | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 |
| 8. Membungkuk, berlutut atau memendak | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 |
| 9. Berjalan lebih dari satu mil | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 |
| 10. Berjalan beberapa blok | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 |
| 11. Berjalan satu blok | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 |
| 12. Mandi atau berpakaian sendiri | ☐ 1 | ☐ 2 | ☐ 3 |

Selama **4 minggu terakhir**, apakah Anda mengalami salah satu masalah berikut dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari lainnya **yang disebabkan oleh kesehatan fisik Anda?**

- | | Ya | Tidak |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 13. Mengurangi jumlah waktu yang Anda habiskan untuk bekerja atau aktivitas lain | ☐ 1 | ☐ 2 |
| 14. Tercapai kurang dari yang Anda inginkan | ☐ 1 | ☐ 2 |
| 15. Dibatasi dalam jenis pekerjaan atau kegiatan lainnya | ☐ 1 | ☐ 2 |
| 16. Mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas lain (misalnya memerlukan usaha ekstra untuk melakukannya) | ☐ 1 | ☐ 2 |

Selama **4 minggu terakhir**, apakah Anda mengalami salah satu masalah berikut dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari lainnya **yang disebabkan oleh masalah emosional** (seperti perasaan tertekan atau cemas)?

- | | Ya | Tidak |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 17. Mengurangi jumlah waktu yang Anda habiskan untuk bekerja atau aktivitas lain | ☐ 1 | ☐ 2 |
| 18. Tercapai kurang dari yang Anda inginkan | ☐ 1 | ☐ 2 |
| 19. Tidak melakukan pekerjaan atau aktivitas lain dengan hati-hati seperti biasanya | ☐ 1 | ☐ 2 |
-

20. Selama **4 minggu terakhir**, sejauh mana kesehatan fisik atau masalah emosional Anda mengganggu aktivitas sosial normal Anda dengan keluarga, teman, tetangga, atau kelompok?

- ☐ 1 – Tidak sama sekali
- ☐ 2 – Agak
- ☐ 3 – Cukup
- ☐ 4 – Lumayan
- ☐ 5 – Sangat

21. Seberapa parah nyeri **tubuh** yang Anda alami selama **4 minggu terakhir**?

- ☐ 1 – Tidak ada
- ☐ 2 – Sangat ringan
- ☐ 3 – Ringan
- ☐ 4 – Sedang
- ☐ 5 – Parah
- ☐ 6 – Sangat parah

22. Selama 4 minggu terakhir, seberapa besar nyeri mengganggu pekerjaan normal Anda (termasuk pekerjaan di luar rumah dan pekerjaan rumah tangga)?

- ☐ 1 – Tidak sama sekali
 - ☐ 2 – Sedikit nyeri
 - ☐ 3 – Cukup nyeri
 - ☐ 4 – Lumayan nyeri
 - ☐ 5 – Sangat nyeri
-

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tentang perasaan Anda dan keadaan Anda selama 4 minggu terakhir. Untuk setiap pertanyaan, berikan satu jawaban yang paling mendekati perasaan anda dengan memberi tanda (V) pada kolom yang telah disediakan.

Berapa banyak waktu selama **4 minggu terakhir...**

	Sepanjang waktu	Sering kali	Agak sering	Agak jarang waktu	Sedikit waktu	Tidak pernah
23. Apakah Anda merasa penuh semangat?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
24. Apakah Anda termasuk orang yang sangat gugup?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
25. Pernahkah Anda merasa sangat sedih sehingga tidak ada yang bisa menghibur Anda?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
26. Apakah anda merasa tenang dan damai?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
27. Apakah Anda mempunyai banyak energi?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
28. Pernahkah Anda merasa putus asa dan sedih?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
29. Apakah Anda merasa lelah?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
30. Apakah Anda termasuk orang yang bahagia?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6
31. Apakah anda merasa lelah?	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5	☐ 6

32. Selama **4 minggu terakhir**, seberapa sering **masalah kesehatan fisik atau emosional Anda** mengganggu aktivitas sosial Anda (seperti mengunjungi teman, saudara, dll.)?

☐ 1 – Sepanjang waktu

-
- ☐ 2 - Seringkali
 - ☐ 3 – Kadang-kadang
 - ☐ 4 - Sese kali
 - ☐ 5 – Tidak pernah

Seberapa BENAR atau SALAH **setiap** pernyataan berikut untuk Anda.

	Sangat benar	Sebagian besar bena	Tidak tahu	Sebagian besar salah	Sangat salah
33. Sepertinya saya lebih mudah sakit dibandingkan orang lain	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
34. Saya sama sehatnya dengan siapa pun yang saya kenal	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
35. Saya memperkirakan kesehatan saya akan memburuk	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
36. Kesehatan saya sangat baik	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

Kuesioner Persepsi Penyakit Singkat

Silakan lingkari nomor yang paling sesuai menurut pandangan Anda untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Seberapa besar penyakit Anda mempengaruhi hidup Anda?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak berpengaruh									Sangat	
Sama sekali									berpengaruh	

Menurut Anda, berapa lama penyakit Anda akan berlangsung?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dalam waktu									Selamanya	
Sangat singkat										

Menurut Anda, seberapa besar Anda memiliki kendali terhadap penyakit Anda?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak punya									kendali	
Kendali Sama sekali									sangat besar	

Menurut Anda, seberapa besar pengobatan dapat membantu menyembuhkan penyakit Anda?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak									Sangat	
Sama sekali									membant	

Seberapa sering Anda mengalami gejala penyakit Anda?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak ada gejala									Banyak	
Sama sekali									gejala parah	

Seberapa khawatir Anda terhadap penyakit Anda?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak khawatir									Sangat	
Sama sekali									khawatir	

Menurut Anda, seberapa baik Anda memahami penyakit Anda?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak paham									angap paham	
Sama sekali									dengan jelas	

Seberapa jauh penyakit Anda mempengaruhi emosi Anda? (misal apakah hal itu membuat Anda marah, takut, sedih, bahkan depresi?)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak berpengaruh									sangat	
Sama sekali pada emosi									berpengaruh	

Silakan urutkan berdasarkan tiga faktor penyebab utama yang Anda yakini menjadi penyebab penyakit Anda! Beberapa faktor penyebab utama menurut saya antara lain:

- 1.
- 2.
- 3.

Kuisiomer MMAS-8

Berikut ini adalah daftar pertanyaan. Silakan tandai hal mana yang Anda setuju atau tidak setuju pada kolom yang tersedia di setiap pertanyaan. Tidak ada jawaban benar atau salah. Berikan jawaban yang jujur; jika tidak, hasilnya tidak valid.

NO	8 Pertanyaan Skala Kepatuhan Pengobatan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah Anda terkadang lupa minum obat diabetes?		
2	Terkadang orang tidak meminum obatnya karena alasan lain selain lupa. Selama dua minggu terakhir, adakah hari-hari di mana Anda tidak meminum obat diabetes?		
3	Pernahkah Anda mengurangi atau berhenti minum obat Diabetes tanpa memberitahu dokter karena Anda merasa lebih buruk saat meminumnya?		
4	Saat bepergian, Apakah Anda terkadang lupa membawa obat diabetes?		
5	Apakah Anda minum obat diabetes kemarin?		
6	Ketika Anda merasa penyakit diabetes Anda sudah terkendali, apakah Anda terkadang berhenti minum obatnya?		
7	Minum obat setiap hari merupakan ketidaknyamanan yang nyata bagi sebagian orang. Pernahkah Anda merasa kerepotan dalam mematuhi rencana pengobatan Diabetes Anda?		
8	Seberapa sering Anda kesulitan mengingat untuk minum semua obat diabetes Anda?		